

Señales de alerta en el desarrollo del lenguaje infantil: ¿cuándo consultar a un fonoaudiólogo?

Qué entendemos por “señales de alerta” en la comunicación y el lenguaje

Una señal de alerta no es un diagnóstico. Es una observación —de la familia, del pediatra o del propio profesional en fonoaudiología— que indica que conviene mirar con más detalle cómo está progresando la comunicación de un niño o niña. La mayoría de las señales de alerta, tomadas de forma aislada, no equivalen a un trastorno: el desarrollo infantil presenta una variabilidad considerable, y muchos niños que muestran una señal puntual continúan su desarrollo dentro de lo esperado.

Dicho esto, la evidencia respalda que ciertas observaciones justifican una consulta oportuna. Una revisión clínica reciente publicada en *American Family Physician* señala que los médicos de atención primaria cumplen un papel central en la identificación temprana de estas dificultades, y que la referencia oportuna a fonoaudiología puede reducir el riesgo de que una dificultad de comunicación se convierta en un trastorno de mayor impacto a largo plazo (Rupert et al., 2023). Este artículo recorre qué observar, por qué hacerlo de forma integral, y cuándo tiene sentido pedir una valoración profesional.

Por qué observar el desarrollo de forma integral, no solo contar palabras

Es comprensible que muchas familias midan el progreso de su hijo o hija por la cantidad de palabras que dice. Sin embargo, el vocabulario expresivo es solo una de varias dimensiones del lenguaje. La comprensión (lo que el niño entiende, aunque no lo diga), la manera en que usa gestos y sostiene la interacción, la articulación de los sonidos, la capacidad de combinar palabras y de participar en un intercambio comunicativo son igualmente relevantes. Rupert et al. (2023) distinguen explícitamente entre dificultades de comprensión (lenguaje receptivo) y de expresión (lenguaje expresivo), señalando que ambas merecen atención, y que una de las preguntas clave en la historia clínica es si el niño combina dos palabras hacia los dos años, no únicamente cuántas palabras conoce.

Mirar solo el número de palabras puede llevar a dos errores opuestos: alarmarse por una variación normal en el vocabulario, o pasar por alto una dificultad de comprensión, de articulación o de interacción social que no se refleja en un simple conteo.

Señales que pueden observarse en distintas etapas del desarrollo

Los rangos de edad que siguen son orientativos, no reglas rígidas. Proviene de listados de hitos revisados por la Academia Americana de Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que fijan cada hito en la edad en que aproximadamente el 75 % de los niños ya lo demuestra (Rupert et al., 2023). Esto significa que una parte considerable de los niños típicos alcanza estos hitos algo más tarde sin que ello indique, por sí solo, un trastorno.

Algunas observaciones que, según esta guía clínica, conviene comentar con un profesional incluyen: ausencia de sonidos distintos al llanto o de respuesta a estímulos sonoros en los primeros meses; falta de balbuceo variado o de gestos como señalar hacia el final del primer año; un vocabulario notablemente

reducido —hablando de forma orientativa, menos de 50 palabras— o ausencia de combinaciones de dos palabras a los 24 meses o más; y un habla que continúa siendo mayormente incomprensible para adultos fuera del entorno familiar después de los tres años (Rupert et al., 2023).

Comprensión, expresión, vocabulario, combinación de palabras e interacción

No todas las dificultades de comunicación son del mismo tipo, y la distinción orienta tanto la observación de la familia como la valoración profesional:

- **Dificultades de comprensión (lenguaje receptivo):** el niño parece no entender instrucciones simples o palabras conocidas para su edad, más allá de lo que se explica por distracción o por el contexto.
- **Dificultades de expresión (lenguaje expresivo):** el niño comprende razonablemente bien, pero le cuesta producir palabras, frases o sonidos del habla acordes a su edad.
- **Vocabulario y combinación de palabras:** un vocabulario expresivo marcadamente reducido, o la ausencia de combinaciones de palabras varios meses después de lo orientativo para su edad.
- **Interacción comunicativa:** dificultades para compartir atención con otros, iniciar intercambios comunicativos o sostener una conversación breve, independientemente del tamaño del vocabulario.

Esta distinción es relevante porque el consenso internacional CATALISE —que reúne a un panel multidisciplinario de expertos en lenguaje infantil— recomienda no tratar el lenguaje como una categoría única, sino reconocer perfiles distintos de dificultad, algunos asociados a otras condiciones del desarrollo y otros no (Bishop et al., 2017). Un niño puede tener una dificultad principalmente expresiva con comprensión conservada, y ese patrón orienta de forma distinta la valoración y el acompañamiento.

La importancia de la edad y la trayectoria individual

Una misma observación puede tener un peso muy distinto según la edad del niño y según se trate de un hallazgo aislado o de un patrón sostenido en el tiempo. La revisión de Rupert et al. (2023) señala, por ejemplo, que las dificultades expresivas identificadas después de los cuatro años tienden a ser más predictivas de un desenlace a largo plazo que las identificadas antes de esa edad, lo que respalda observar la trayectoria completa —y no solo una fotografía puntual— antes de sacar conclusiones. De igual manera, factores como el sexo, antecedentes de bajo peso al nacer o dificultades auditivas sostenidas se asocian con mayor probabilidad de dificultades de lenguaje, sin que esto determine un desenlace individual (Rupert et al., 2023).

También vale la pena aclarar un punto que suele generar confusión: crecer en un entorno bilingüe no se asocia, por sí solo, a un mayor riesgo de dificultades de lenguaje, aunque los niños bilingües puedan mostrar puntuaciones distintas en pruebas estandarizadas diseñadas para un solo idioma (Rupert et al., 2023).

Qué situaciones pueden justificar una consulta con un profesional en fonoaudiología

Más allá de un hito puntual, ciertas situaciones ameritan buscar orientación profesional con relativa prontitud:

- **Pérdida de habilidades previamente adquiridas.** Que un niño deje de usar palabras, gestos o sonidos que ya dominaba es una señal que debe evaluarse sin demora, ya que puede asociarse a distintas condiciones del desarrollo (Rupert et al., 2023).
- **Dificultades persistentes de comprensión o expresión,** sostenidas en el tiempo y no explicadas por una situación puntual (cansancio, un cambio reciente, timidez ante un desconocido).
- **Dificultades importantes para comunicarse,** incluyendo un habla que resulta difícil de entender para personas fuera del entorno cercano después de los tres años.
- **Ausencia o escasa progresión de habilidades comunicativas clave** cuando ya ha pasado un tiempo razonable de observación, considerando el rango de edad correspondiente.
- **Preocupación persistente de la familia,** incluso cuando no se identifica un hito único que la explique. La opinión y observación de quienes conviven a diario con el niño tiene valor clínico por sí misma (Rupert et al., 2023).
- **Dificultades que interfieren con la participación cotidiana:** juego con otros niños, seguimiento de rutinas, adaptación al entorno escolar o expresión de necesidades básicas.

Conviene aclarar un matiz importante sobre el “screening” o tamizaje universal. En 2024, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) concluyó que la evidencia actual es insuficiente para recomendar a favor o en contra de aplicar un tamizaje sistemático de lenguaje a niños de 5 años o menos que no presentan señales ni preocupación por parte de la familia o el profesional (Barry et al., 2024). Es fundamental no confundir esta conclusión con una recomendación en contra de evaluar a los niños que sí muestran señales o generan preocupación: la propia guía aclara que, ante señales o inquietud familiar, la referencia a una valoración específica sigue siendo la conducta recomendada (Barry et al., 2024; Jullien, 2021). Es decir, la incertidumbre científica se refiere al tamizaje poblacional de niños sin ningún indicio, no a la utilidad de evaluar a un niño concreto cuando existe un motivo de consulta.

Qué puede ocurrir durante una valoración fonoaudiológica

Una valoración fonoaudiológica no es un procedimiento invasivo ni una prueba de una sola pregunta. Habitualmente incluye una entrevista con la familia sobre la historia del desarrollo, antecedentes médicos y observaciones cotidianas; la aplicación de instrumentos estandarizados adecuados para la edad del niño; y la observación directa de sus habilidades comunicativas, articulatorias y de interacción. Cuando corresponde, se coordina también una evaluación auditiva, dado que las dificultades de audición no diagnosticadas son una causa frecuente y tratable de retraso en el lenguaje (Rupert et al., 2023).

El resultado de esta valoración puede ser muy diverso: desde confirmar que el desarrollo se encuentra dentro de lo esperado, hasta identificar una dificultad puntual que se beneficia de pautas de estimulación en casa, o bien recomendar un proceso de intervención más estructurado.

Por qué consultar no significa necesariamente que exista un diagnóstico

Buscar una valoración profesional es un acto de cuidado, no una confirmación de que algo anda mal. Muchos niños evaluados por una señal de alerta puntual resultan tener un desarrollo dentro del rango esperado, o bien pequeñas variaciones que se resuelven con el tiempo y el acompañamiento adecuado.

La propia evidencia científica reconoce esta variabilidad: no toda dificultad detectada en la primera infancia se traduce en un trastorno persistente (Jullien, 2021).

Al mismo tiempo, cuando sí existe una dificultad, identificarla temprano amplía las opciones de acompañamiento, en lugar de reducirlas. Por eso, ni la ausencia de señales garantiza que todo seguirá su curso sin necesidad de observación, ni la presencia de una señal aislada implica un diagnóstico. Consultar es, sencillamente, la manera más informada de saber en qué punto se encuentra el niño.

Qué pueden hacer las familias mientras buscan orientación profesional

Mientras se gestiona una cita o se espera una valoración, las familias no están —ni deben sentirse— en un compás de espera pasivo:

- **Sostener la interacción cotidiana:** seguir hablando, jugando y respondiendo a los intentos comunicativos del niño, sin presionar para que “hable” ni corregir de forma insistente.
- **Registrar observaciones concretas:** qué dice, qué gestos usa, en qué situaciones se comunica mejor o peor, para compartirlas con el profesional.
- **Evitar la comparación estricta con otros niños,** incluyendo hermanos, dado el margen de variabilidad individual ya señalado.
- **No postergar la consulta por temor a “alarmar” o a recibir un diagnóstico:** como se explicó, consultar no equivale a diagnosticar, y permite descartar o confirmar con información real, en lugar de con incertidumbre.

Reconocer una señal de alerta no es motivo de alarma ni de culpa: es una oportunidad para observar con más cuidado y, si corresponde, acompañar a tiempo. “Estimular con intención cambia trayectorias” — y esa intención incluye saber cuándo pedir ayuda profesional.

Título SEO

Señales de alerta en el lenguaje infantil: ¿cuándo consultar a un fonoaudiólogo?

Meta descripción

Qué señales de alerta del lenguaje infantil observar en cada etapa, por qué una señal aislada no es un diagnóstico, y cuándo conviene consultar a un fonoaudiólogo, con respaldo científico actualizado.

URL sugerida

/senales-alerta-lenguaje-infantil-cuando-consultar-fonoaudiologo

Referencias

- Barry, M. J., Nicholson, W. K., Silverstein, M., Chelmsow, D., Coker, T. R., Davis, E. M., Donahue, K. E., Jaén, C. R., Li, L., Mangione, C. M., Ogedegbe, G., Rao, G., Ruiz, J. M., Stevermer, J., Tsevat, J., Underwood, S. M., & Wong, J. B. (2024). Screening for speech and language delay and disorders in children: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *JAMA*, 331(4), 329–334. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.26952>
- Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., & CATALISE Consortium. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(10), 1068–1080. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12721>
- Jullien, S. (2021). Screening for language and speech delay in children under five years. *BMC Pediatrics*, 21(Suppl 1), 362. <https://doi.org/10.1186/s12887-021-02817-7>
- Rescorla, L. (2011). Late talkers: Do good predictors of outcome exist? *Developmental Disabilities Research Reviews*, 17(2), 141–150.
- Rupert, J., Hughes, P., & Schoenherr, D. (2023). Speech and language delay in children. *American Family Physician*, 108(2), 181–188.

Control de evidencia

1. Principales fuentes utilizadas

Rupert et al. (2023, American Family Physician) como eje clínico principal (hitos, factores de riesgo, criterios de referencia); Barry et al. (2024, USPSTF/JAMA) y Jullien (2021, BMC Pediatrics) para precisar el alcance real del debate sobre el tamizaje universal; Bishop et al. (2017, consenso CATALISE) para la terminología y los distintos perfiles de dificultad del lenguaje.

2. Afirmaciones importantes que respaldan

Los rangos de edad orientativos y las señales de referencia inmediata (pérdida de habilidades, dificultades persistentes, habla incomprensible después de los tres años) provienen de Rupert et al. (2023). La distinción entre “tamizaje poblacional sin señales” y “evaluación ante señales o preocupación familiar” proviene directamente de Barry et al. (2024) y Jullien (2021). La distinción entre perfiles de dificultad del lenguaje proviene de Bishop et al. (2017).

3. Fuentes anteriores a 2021

Se utilizó Bishop et al. (2017) porque es el consenso internacional de terminología vigente en fonoaudiología (CATALISE), sin una actualización posterior que lo sustituya. Se utilizó Rescorla (2011) porque continúa siendo la referencia central sobre desenlaces en “hablantes tardíos” y no se identificó, dentro del alcance de esta búsqueda, un estudio longitudinal reciente que reemplace sus hallazgos.

4. Aspectos modificados o matizados a partir de la evidencia

Se reformuló cualquier lista de señales para evitar que se leyera como regla rígida (“si a los X meses no hace Y, tiene un problema”), enmarcando los rangos como orientativos (75 % de los niños). Se incorporó explícitamente el matiz del USPSTF 2024 para evitar que la falta de evidencia sobre tamizaje universal se malinterprete como una razón para no evaluar a un niño con señales o preocupación familiar real. Se evitó cualquier formulación que sugiriera autodiagnóstico o que equiparara una señal aislada con un trastorno.